Estratégia MED



CIRURGIA

PROF. RENATHA PAIVA

ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



APRESENTAÇÃO:

PROF. RENATHA PAIVA

Meu querido aluno! De todos os tipos de abdome agudo, o abdome agudo hemorrágico é o menos cobrado nas provas. Por esse motivo, coloquei neste resumo apenas as patologias que costumam cair. Se surgir alguma dúvida durante sua leitura, não se esqueça de que nosso livro-texto está mais completo e detalhado.

@prof.renathapaiva

@estrategiamed

Estratégia MED

/estrategiamed

@estrategiamed

t.me/estrategiamed

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO 4
1.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO 4
1.2 TRATAMENTO 4
2.0 GRAVIDEZ ECTÓPICA ROTA 5
2.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO 6
2.2 DIAGNÓSTICO 6
2.3 TRATAMENTO 7
3.0 CISTO OVARIANO ROTO 8
3.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO 8
3.2 DIAGNÓSTICO 8
3.3 TRATAMENTO 9
4.0 ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL ROTO 10
4.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO 11
4.2 DIAGNÓSTICO 11
4.3 TRATAMENTO 12
5.0 LISTA DE QUESTÕES 16
6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 17
7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 18

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
1.0 INTRODUÇÃO

O abdome agudo hemorrágico caracteriza-se pela presença de sangue livre na cavidade abdominal (hemoperitônio) de origem não traumática. Não o confunda com hemorragia digestiva, em que o sangue está dentro do trato gastrointestinal e não livre na cavidade peritoneal.

São exemplos de abdome agudo hemorrágico:



Gravidez ectópica rota (causa mais comum)
Cisto ovariano roto
Ruptura de aneurisma de aorta abdominal (AAA)
Ruptura de aneurisma de artéria esplênica (aneurisma visceral mais comum)
Ruptura esplênica e hepática espontânea
Adenoma hepático roto (tumor hepático que mais se rompe – mulher jovem em uso de ACO)
Discrasias sanguíneas

1.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO

Geralmente o paciente apresenta-se com **dor abdominal intensa** associada a alterações hemodinâmicas secundárias à perda sanguínea, como palidez cutaneomucosa, sudorese fria, pulsos filiformes, taquicardia, taquipneia, hipotensão arterial e rebaixamento do nível de consciência. Dessa forma, sempre devemos suspeitar de um abdome agudo hemorrágico no paciente com **dor abdominal aguda e CHOQUE HIPOVOLÊMICO.**

A maioria dos autores descreve o **sinal de Lafond**, dor referida no ombro, para patologias ginecológicas, e o **sinal de Kehr** (dor no ombro esquerdo) para ruptura esplênica, ambos causados por irritação do nervo frênico no diafragma pelo sangue livre na cavidade peritoneal.

DOR ABDOMINAL AGUDA + CHOQUE HIPOVOLÊMICO = ABDOME AGUDO HEMORRÁGICO

1.2 TRATAMENTO

O tratamento do abdome agudo hemorrágico, assim como o do trauma abdominal com lesão de víscera maciça, envolve **tratar o choque**, ou seja, hidratação endovenosa com cristaloide através de acesso venoso periférico, transfusão sanguínea (se necessária) **e controle da hemorragia imediato,** quase sempre cirúrgico, por meio de laparotomia exploradora. Lembre-se de que a laparoscopia está contraindicada no paciente instável hemodinamicamente.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

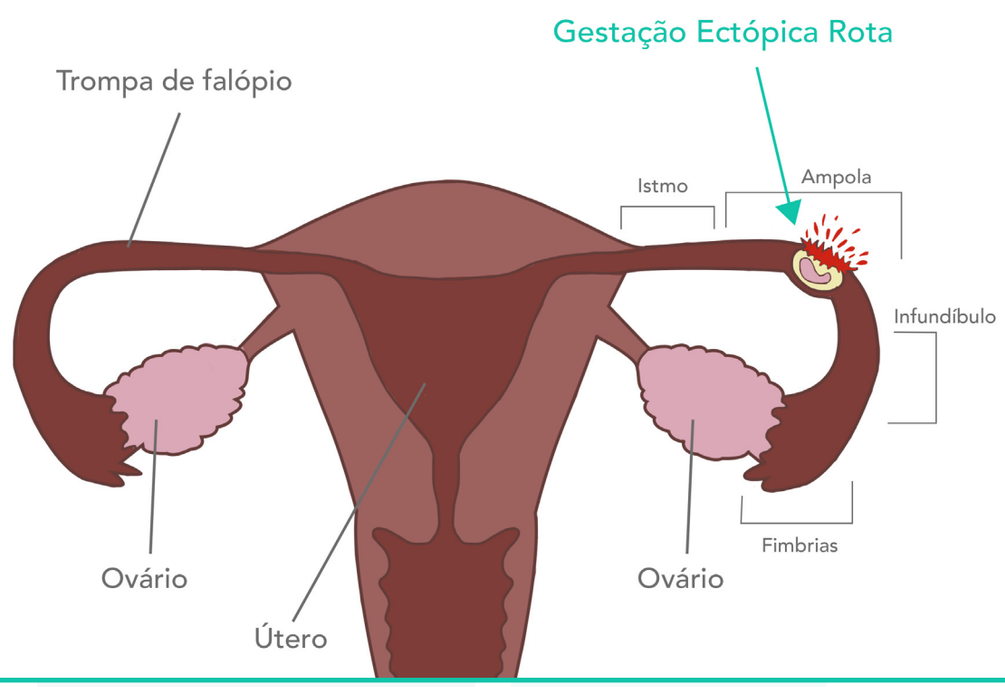
CAPÍTULO

2.0 GRAVIDEZ ECTÓPICA ROTA

A prenhez ou gravidez ectópica rota é a **causa mais comum do abdome agudo hemorrágico.**

A maioria dos casos de gravidez ectópica ocorre na tuba uterina (96%) e é mais frequente do lado direito. A localização mais comum da gestação ectópica é na região ampular da tuba uterina, no entanto a rotura é mais frequente na região ístmica.

GRAVIDEZ ECTÓPICA ROTA



TOME NOTA!

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA GESTAÇÃO ECTÓPICA

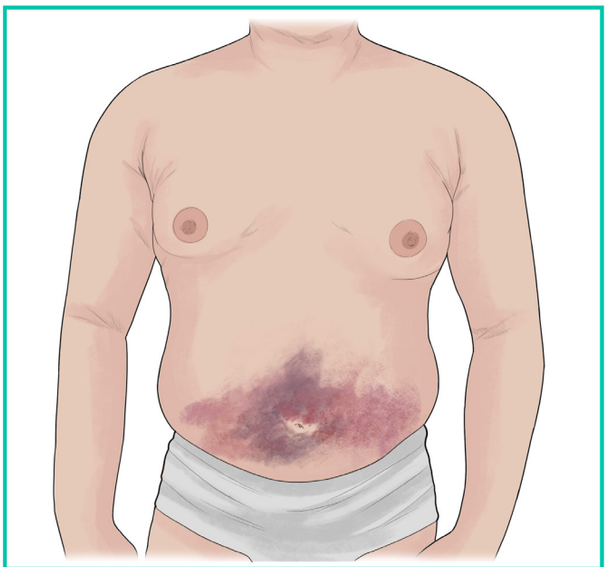
- História de doença inflamatória pélvica
- Gravidez tubária anterior
- Cirurgia tubária anterior
- História de endometriose
- Dispositivo intrauterino permanente (DIU)
- Tabagismo

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO

Devemos suspeitar de um abdome agudo hemorrágico por gravidez ectópica rota na **paciente em idade reprodutiva**, com histórico de **amenorreia, sangramento vaginal anormal,** que cursa com **dor abdominal súbita**, de forte intensidade, contínua, inicialmente no abdome inferior, e **sinais de choque** (taquicardia, hipotensão, sudorese, lipotimia). Se houver sangramento intra-abdominal suficiente para atingir o diafragma, ela pode apresentar dor no ombro, devido à irritação diafragmática (sinal de Lafond).

Um sinal clínico que também pode estar presente é o sinal de Cullen, que consiste na presença de equimose periumbilical, indicativo de hemorragia intra-abdominal. No exame especular, pode haver abaulamento do fundo de saco de Douglas, indicando a presença de hemoperitônio. No toque vaginal, ao comprimir-se o fundo de saco, a paciente apresenta dor de forte intensidade, sinal conhecido como **"sinal de Proust" ou "grito de Douglas".**



SINAL DE CULLEN
(equimose periumbilical)

2.2 DIAGNÓSTICO

O diagnóstico é baseado no quadro clínico de dor abdominal aguda, **história de atraso menstrual, sangramento vaginal e sinais de choque, em uma paciente em idade fértil, com BHCG positivo** e ultrassonografia abdominal e/ou transvaginal evidenciando:

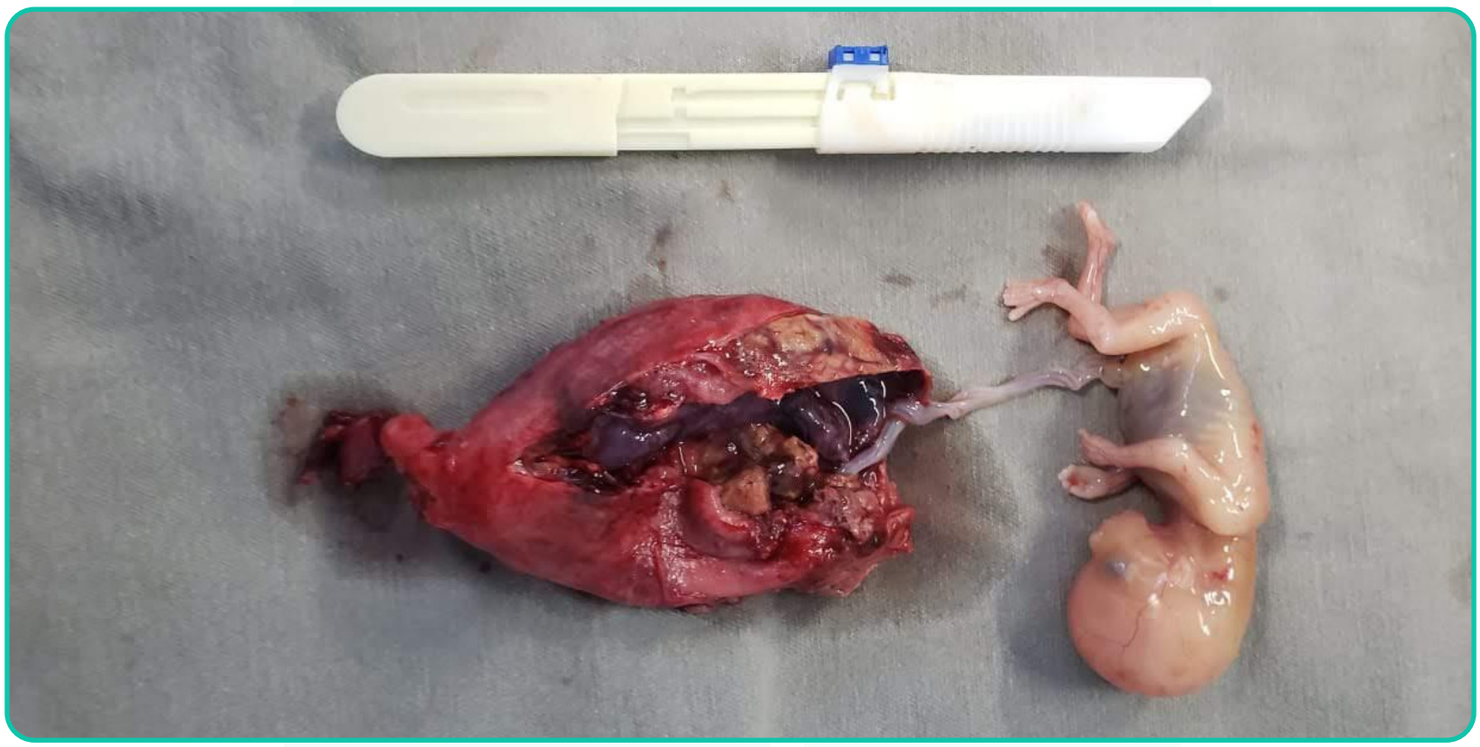
- Líquido livre na cavidade (hemoperitônio);
- Ausência de gestação intrauterina;
- Massa extrauterina complexa (saco gestacional), geralmente na tuba uterina.

GESTAÇÃO ECTÓPICA = BHCG SEMPRE POSITIVO

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

2.3 TRATAMENTO

O tratamento da gravidez ectópica rota é cirúrgico de emergência, e a cirurgia mais comumente realizada é a **salpingectomia**. Geralmente o acesso à cavidade abdominal é por laparotomia convencional, uma vez que instabilidade hemodinâmica é contraindicação à laparoscopia.



FIQUE ATENTO!

GRAVIDEZ ECTÓPICA ROTA

- **Clínica:** dor abdominal súbita e intensa, amenorreia, sangramento vaginal anormal e sinais de choque.
- **Diagnóstico:** BHCG positivo, USG com massa extrauterina (geralmente na trompa), ausência de gestação intrauterina e líquido livre (hemoperitônio).
- **Tratamento:** laparotomia e salpingectomia.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

3.0 CISTO OVARIANO ROTO

A ruptura fisiológica de pequenos cistos foliculares que ocorre a cada ciclo ovulatório geralmente não é significativa clinicamente. Na maioria das mulheres, é assintomática ou há dor leve no meio do ciclo (também conhecida como *mittelschmerz* ou "dor do meio"). Mas, pode ocorrer sangramento significativo e evoluir para um abdome agudo hemorrágico.

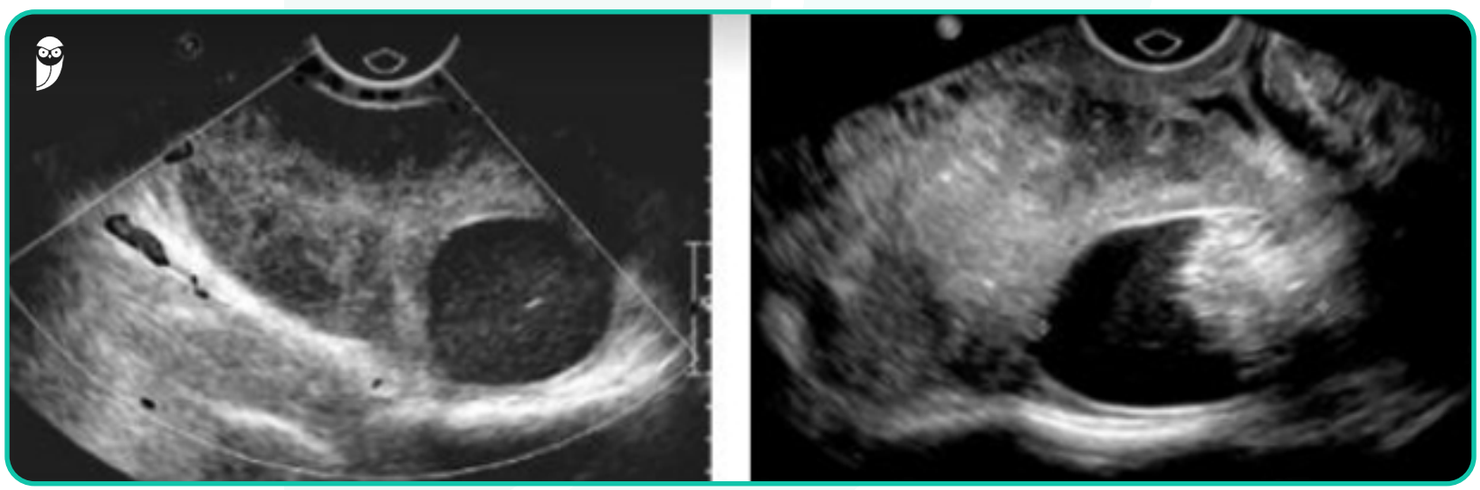
3.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO

A apresentação clássica da ruptura de cisto ovariano é o **início súbito de dor intensa, unilateral** e localizada no quadrante inferior do abdome (direito ou esquerdo), **geralmente durante atividades físicas extenuantes, como exercícios ou relações sexuais**. Assim como na gravidez ectópica rota, pode apresentar os sinais de Lafond e de Cullen.

3.2 DIAGNÓSTICO

As causas ginecológicas mais comuns de hemoperitônio são a ruptura de cisto ovariano e gravidez ectópica. Por isso, é **importante excluir a gravidez ectópica rota** por meio da dosagem do BHCG, pois é necessário tratamento cirúrgico de emergência.

Excluindo uma prenhez ectópica rota, o diagnóstico de cisto ovariano roto pode ser feito pela ultrassonografia, em que será visualizada **massa anexial e líquido livre na pelve.**



Cisto de ovário. Fonte: prova de acesso direto IAMSPE 2017.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

3.3 TRATAMENTO

Pacientes com ruptura de cisto ovariano geralmente sangram uma quantidade pequena ou moderada e o sangramento é autolimitado, podendo ser conduzida de forma conservadora, com internação, repouso, hidratação endovenosa, analgesia, controle hematimétrico, exame físico e ultrassonografia seriados. No entanto, se a paciente já se apresentar com **instabilidade hemodinâmica ou houver falha durante a observação clínica**, o tratamento deverá ser cirúrgico, com **laparotomia ou laparoscopia** (se estável) e controle da hemorragia por meio de uma **cistectomia ou ooforectomia**.



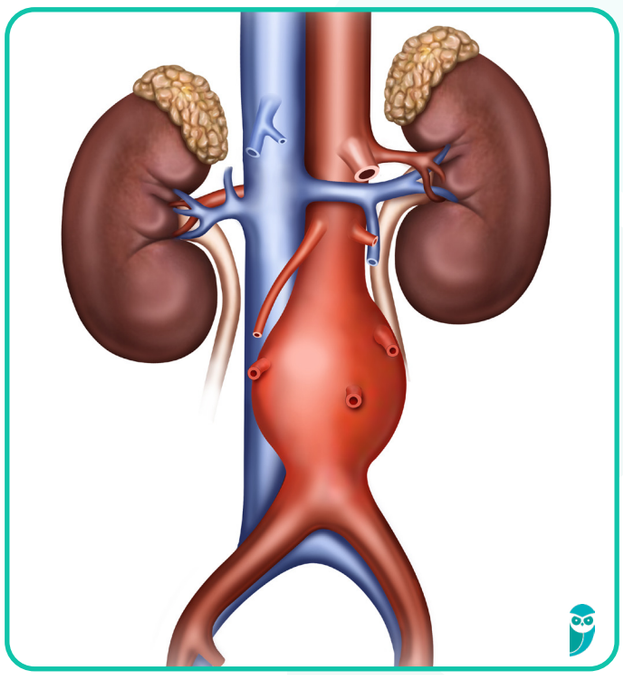
CISTO OVARIANO ROTO

- **Clínica:** dor abdominal súbita, intensa, unilateral, geralmente após relação sexual.
- **Diagnóstico:** BHCG negativo, USG com massa anexial e líquido livre.
- **Tratamento:**
  - **Estável:** observação.
  - **Instável:** tratamento cirúrgico.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

4.0 ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL ROTO



Aneurisma de aorta abdominal infrarrenal (fusiforme).

Meu querido aluno, neste tópico iremos abordar apenas as particularidades do aneurisma de aorta abdominal roto.

O aneurisma da aorta abdominal (AAA) é mais frequente no segmento infrarrenal, e o **principal fator de risco para ruptura de um aneurisma de aorta é o diâmetro**. Um aneurisma ≥ 5,5 cm de diâmetro já tem indicação cirúrgica, e, nessa situação, os benefícios de uma cirurgia de correção do aneurisma sobrepujam os riscos.

Os outros fatores de risco relacionados à rotura do aneurisma estão listados na tabela abaixo.

FATORES DE RISCO DE ROTURA DO AAA
Diâmetro do aneurisma superior a 5,5 cm (diretamente proporcional ao risco de rotura).
Aneurisma sacular.
Crescimento > 0,5 cm em 6 meses ou > 1 cm em um ano.
Aneurismas sintomáticos.
Tabagismo.
Sexo feminino.
DPOC.
Transplantado cardíaco ou renal.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

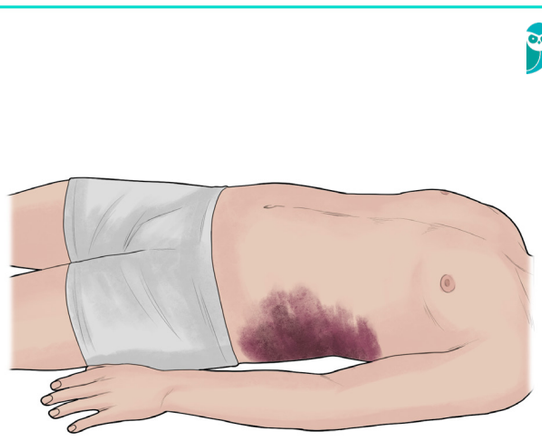
4.1 QUADRO CLÍNICO E EXAME FÍSICO

A **tríade clássica do aneurisma abdominal** roto está presente em 50% dos casos e é composta por:



- Dor abdominal e/ou lombar intensa.
- Hipotensão.
- Massa abdominal pulsátil.

Um sinal clínico que pode estar presente é o **sinal de Grey-Turner, equimose em flancos**, indicativo de hemorragia retroperitoneal (também presente nos casos de pancreatite necro-hemorrágica).



SINAL DE GREY-TURNER
(equimose em flancos)

4.2 DIAGNÓSTICO

ANGIOTOMOGRAFIA: para pacientes com suspeita de rotura de AAA, mas **estáveis hemodinamicamente**. Esse método, além de confirmar o diagnóstico, é útil para o planejamento cirúrgico. Na imagem ao lado, nota-se um grande aneurisma da aorta abdominal com sinais de rotura, caracterizados por extenso hematoma perirrenal, densificação da gordura adjacente e irregularidades do saco aneurismático.

ULTRASSONOGRAFIA: pode ser realizada para pacientes com suspeita de rotura de AAA, **instáveis hemodinamicamente**, sem diagnóstico prévio de AAA, mas **não é obrigatória.** Tem a vantagem de poder ser realizada à beira do leito ou na sala de cirurgia, enquanto o paciente está sendo reanimado, sem causar um atraso indevido no atendimento. Pode ser visualizado um hematoma retroperitoneal, mas o local da ruptura geralmente não é identificado.



Fonte: acervo pessoal – Dr. Joshua Viana.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

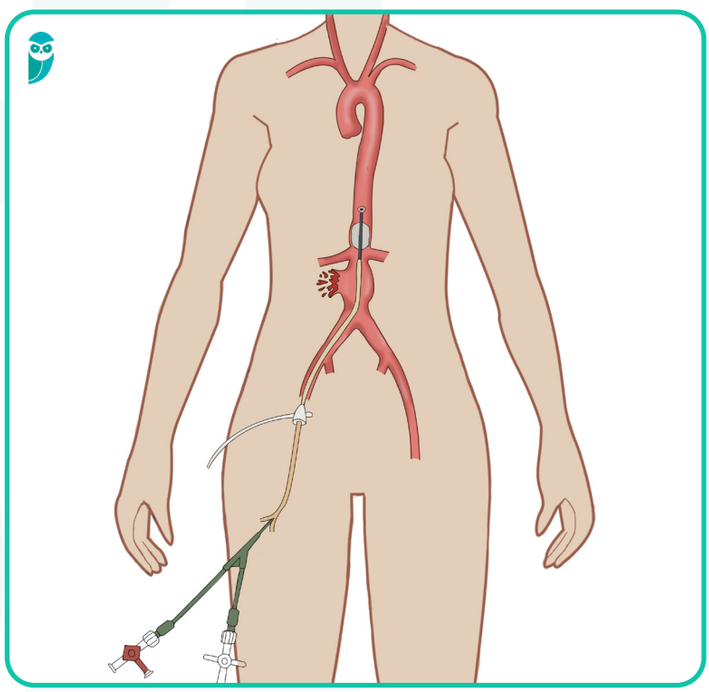


Pacientes **sabidamente portadores de AAA** que se apresentam com **quadro clínico típico** (dor abdominal/dorsal, massa pulsátil e hipotensão) e instabilidade hemodinâmica não necessitam de **nenhum exame complementar** e devem ser levados **imediatamente ao centro cirúrgico** para controle imediato da hemorragia e reparo do aneurisma.

4.3 TRATAMENTO

Quando o AAA roto é identificado, **o reparo deve ser realizado imediatamente** para que o paciente tenha chance de sobrevivência. A reposição volêmica é essencial nessas ocasiões. Apesar disso, a **hipotensão permissiva**, ou seja, evitar reposição volêmica agressiva e permitir uma pressão arterial sistólica tão baixas quanto 50 a 70 mmHg, é uma estratégia útil para prevenir mais lacerações da aorta e limitar a perda sanguínea, devendo ser considerada para os pacientes conscientes, ou seja, sem sinais de hipoperfusão cerebral.

Outra estratégia importante, principalmente nos pacientes instáveis, é a passagem do balão intra-aórtico. Consiste na passagem percutânea de um balão que deverá ser insuflado na aorta proximal ao aneurisma roto, antes do reparo aberto ou endovascular, permitindo, dessa forma, controle do sangramento e melhora hemodinâmica.

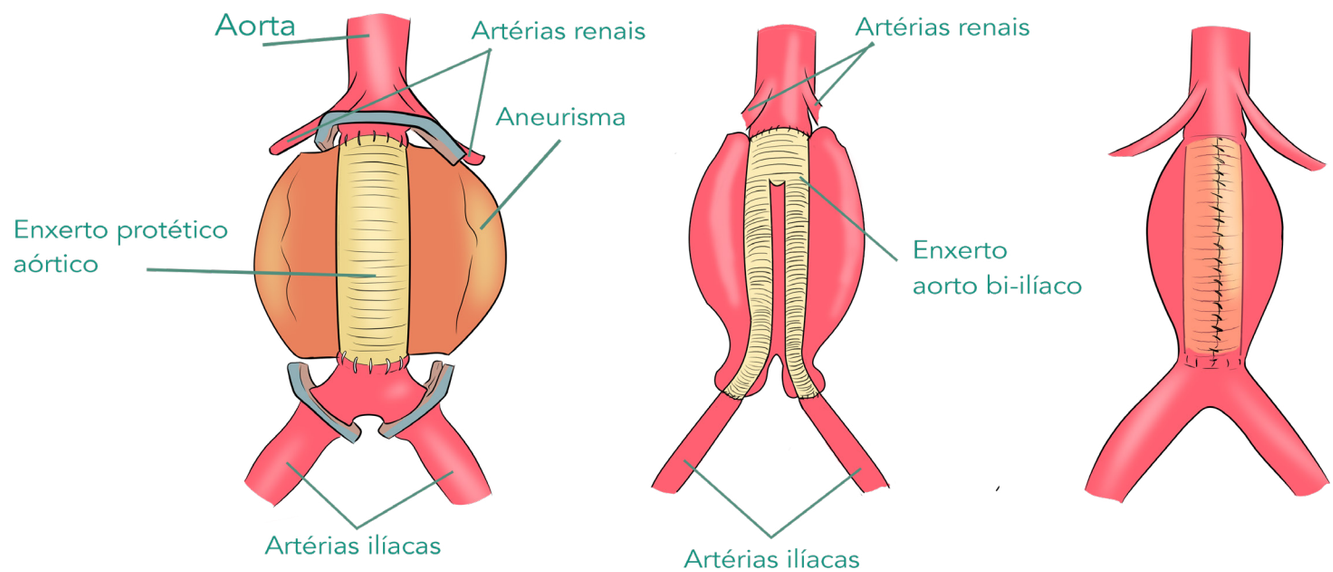


Balão intra-aórtico.

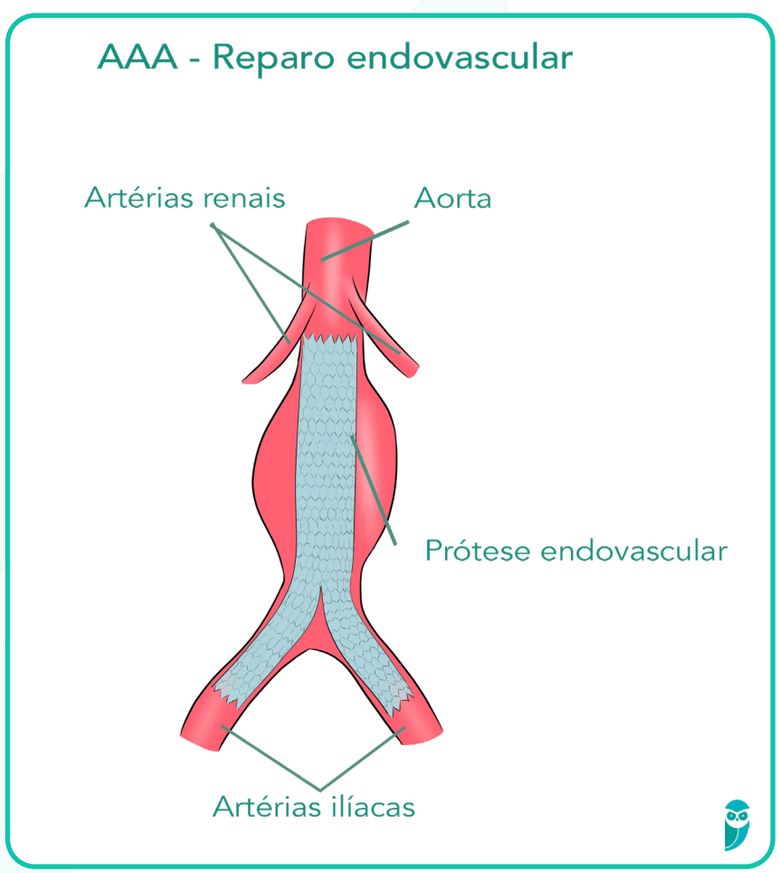
Os aneurismas com ruptura podem ser reparados por dois métodos:

- **Cirurgia aberta convencional:** envolve a substituição do segmento aórtico roto por um enxerto protético, que pode ser simples ou bifurcado. As opções de enxerto são de poliéster (por exemplo, Dacron) e politetrafluoroetileno (PTFE).

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



- **Reparo endovascular (REVA):** é a **via de escolha**, desde que haja disponibilidade e as condições anatômicas do aneurisma permitam. Envolve a colocação de endoprótese aórtica autoexpansível, que reveste a aorta e exclui o saco aneurismático da circulação, geralmente por meio de punção das artérias femorais. O reparo endovascular do AAA roto parece estar associado a uma menor morbidade e mortalidade perioperatória.



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CURIOSIDADE



As principais contraindicações ao reparo endovascular dos aneurismas de aorta abdominal são:

- Aneurismas localizados na altura ou acima das artérias renais.
- Colo aórtico < 0,7 cm.
- Presença de trombo ou calcificação circunferencial na região proximal de fixação da prótese.

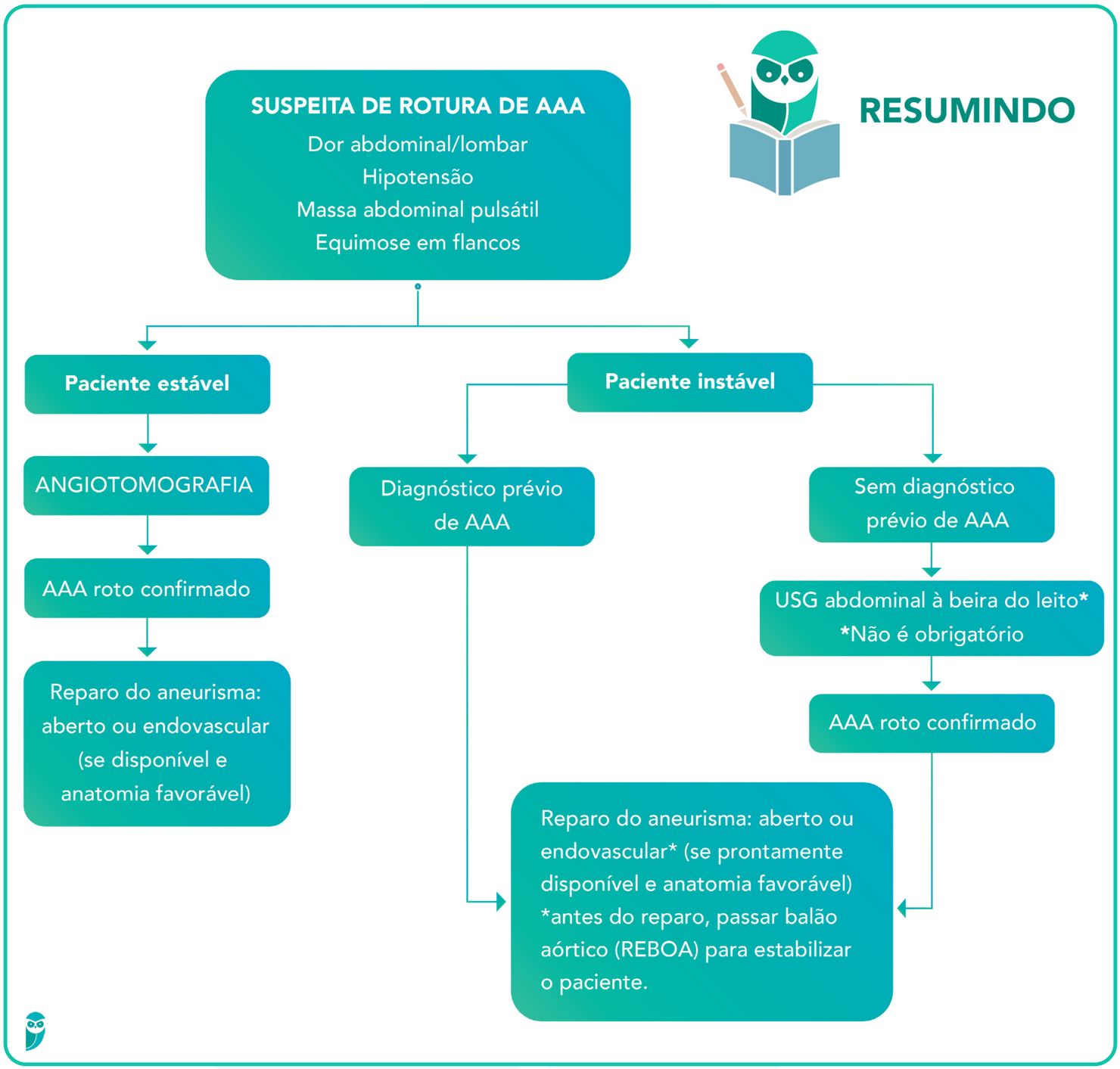
Apesar dos avanços nas técnicas cirúrgicas, na anestesia cardiovascular e nos cuidados intensivos, a mortalidade cirúrgica após o reparo aberto do AAA rompido permanece alta, em torno de 30 a 50%.



Vale a pena lembrar que **uma das complicações no reparo de AAA roto**, e que as bancas adoram cobrar, é a **isquemia colônica**, por ligadura inadvertida da artéria mesentérica inferior, obstrução de seu óstio pela prótese aórtica ou mesmo pela hipotensão severa, comum nesses casos. As manifestações clínicas incluem dor abdominal, principalmente à esquerda, diarreia mucossanguinolenta e febre. O diagnóstico é feito por colonoscopia ou sigmoidoscopia, em que é visualizada mucosa edemaciada, friável, pálida, com nódulos hemorrágicos e transição abrupta (bem delimitada) entre mucosa lesada e normal.

COLITE ISQUÊMICA: UMA DAS PRINCIPAIS COMPLICAÇÕES DO TRATAMENTO DO AAA ROTO

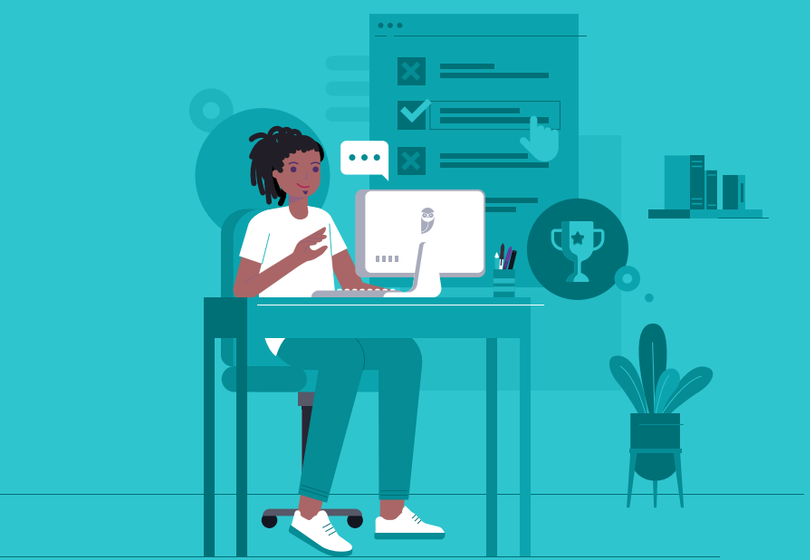
Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/tnXy

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

6.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Sabiston Tratado de Cirurgia – 20ª edição.
2. *UpToDate*.
3. Gravidez ectópica: manifestações clínicas e diagnóstico.
4. Gravidez ectópica: tratamento cirúrgico.
5. Avaliação e tratamento de cisto ovariano rompido.
6. Características clínicas e diagnóstico de aneurisma da aorta abdominal.
7. Tratamento de aneurisma de aorta abdominal sintomático (não rompido) e rompido.
8. Correção cirúrgica e endovascular de aneurisma de aorta abdominal roto.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO

7.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Meu querido aluno, abdome agudo hemorrágico é um tema pouco cobrado, mas com este resumo você conseguirá responder à maioria das questões!

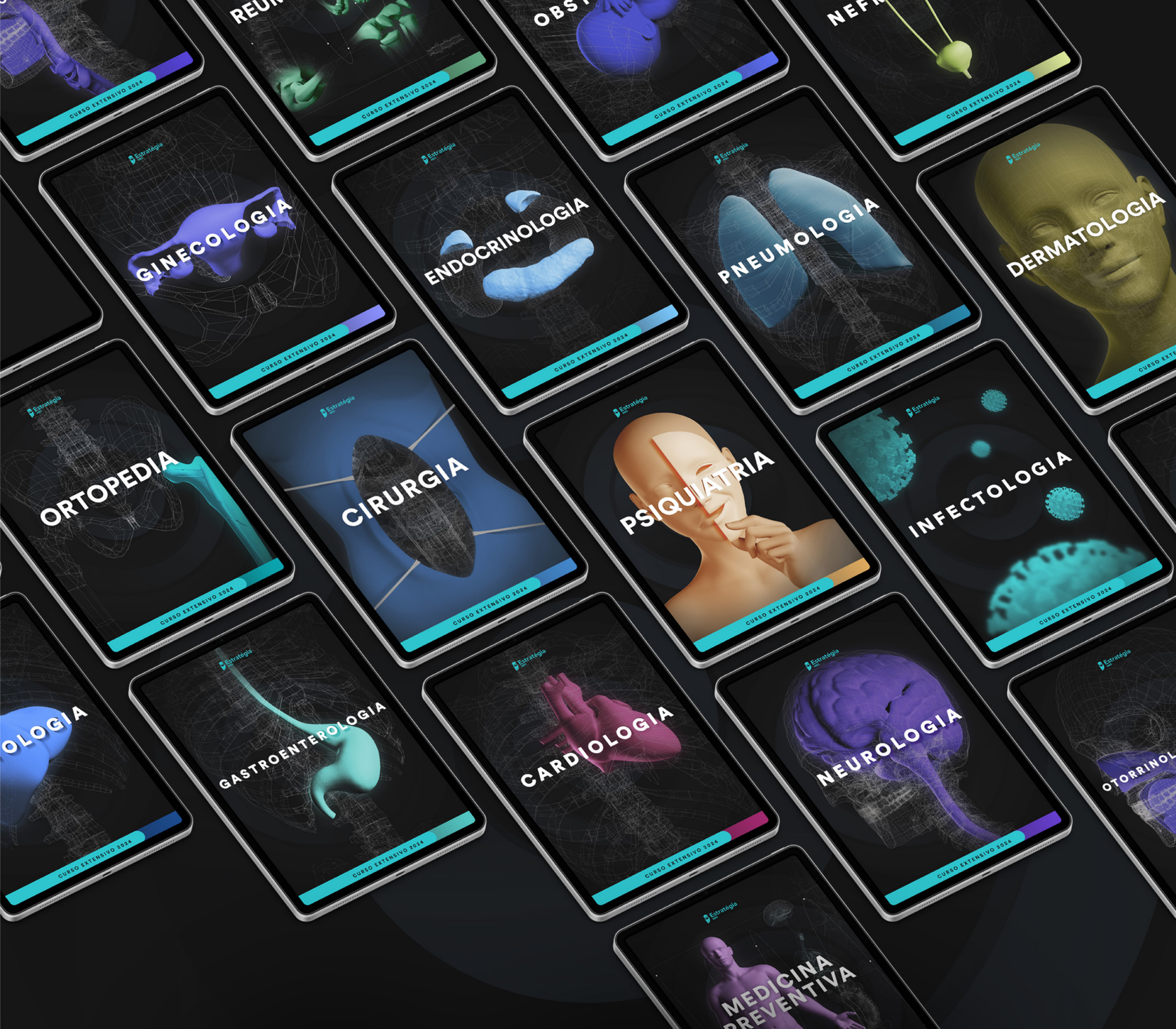
Lembre-se que estou a sua disposição para tirar dúvidas no Fórum de Dúvidas do Estratégia MED.

Bons estudos!!!! Fique com Deus!!!

Abraços,

Renatha Paiva.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina